

Q 13 : – CAT DEVANT UN BRÛLE GRAVE

INTRODUCTION :

- Brûlure = destruction du revêtement cutané et tissus sous-jacents, sv par agent thermique, rarement : agent électrique, chimique ou radiations.
- Souvent accidents domestiques+++, de travail, AVP, tentatives de suicide, incendies, agressions.
- Gravité dépend de la SCB, du degré, du siège, de l'âge, et de la présence de Lésions d'inhalation
- Conséquences pathologiques graves à court terme (pronostic vital) et à long terme (pronostic fonctionnel)
- PEC doit être précoce, intense et multidisciplinaire.

CONDUITE A TENIR :

A-Evaluation initiale :

a. Interrogatoire : Traumatisé : Age, tares, ATCD, heure du dernier repas et statu vaccinal + Traumatisme : Heure exact, circonstance, mécanisme.

b. Examen clinique :

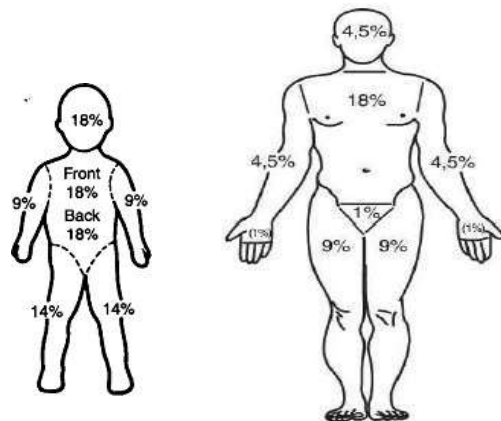
Evaluations des fonctions vitales

Evaluation de gravité :

1. Étendue de surface brûlée : en % de surface corporelle totale (%SC)

a. Règle des 9 de Wallace :

Segment corporel	Surface atteinte	
	Adulte	Enfant
Tête et cou	9%	17%
Face antérieure du tronc	18%	18%
Face postérieure du tronc	18%	18%
Chaque jambe	18%	14%
Chaque bras	9%	9%
Périnée	1%	1%



b. Tables de Lund-Browder : évaluation plus précise surtout l'enfant+++.

c. Paume de main et doigts du patient : équivalents 0,8%SC (homme) et 0,7%SC (femme), surtout pour brûlures peu étendues et disséminées.

2. Profondeur des brûlures :

Premier degré : Erythème, Œdème localisés douloureux → Guérison spontanée en 5j

Deuxième degré Superficiel : Phlyctènes, très douloureux, → Cicatrisation spontanée en 10j.

Deuxième degré Profond : Douleur moindre, rougeur, suintement, → Cicatrisation en 3-4 sm

Troisième degré : Insensible, pas de saignements, peau d'aspect blanc à brun cartonné. → Cicatrisation spontanée impossible

=> PEC chirurgicale : greffe cutanée

3. Localisations à risque :

Zones fonctionnelles : Cervico-faciales (péri-orificielles+++), Mains. Plis de flexion articulaire. Périnée, OGE. Seins (femme)

Brûlures des voies aériennes.

Brûlures circonférentielles (MI, MS, tronc) : crush syndrome par effet garrot.

4. Lésions associées : polytraumatisme, inhalation suie/fumée, intoxication oxycarboné ou cyanhydrique.

⇒ Brûlure grave si :

Superficie >25%SC adulte ou >20% extrêmes âges

Brûlure 3^{ème} degré >10%SC

Localisations à risque

Lésions associées (polytraumatisme...)

Pathologies graves ou non équilibrées préexistantes (ASA II ou plus)

B- Bilan initial :

- NFS, TP, TCA, groupage, ionogramme, GDS, CPK.
- Prélèvement bactériologiques répétés des surfaces brûlées.
- Radiographie thoracique, ECG, TDM corps entier (polytraumatisme).

C-Prise en charge :

1-Premiers secours :

- Refroidissement par eau à 15° pendant 15min.
- Enlever vêtements imprégnés de liquides brûlants ou d'agents chimiques acides ou caustiques.

2-Hospitalisation + MEC + monitoring :

Indications d'hospitalisation :

SCB >10%SC (5% extrêmes âges)

Traumatismes,

Lésion respiratoire (blast)

Localisations à risque

Tares associées

Brûlures électriques, chimiques, radiations, intoxications associées

Mise en condition : 2VVP voire VVC, PAI, sonde gastrique, sondage urinaire.

Monitoring (scope, PA, SpO2, T, diurèse : 0,5-1cc/kg/h°)

3-Traitement médical :

a-Correction détresses vitales :

- A : Assurer la liberté des voies aériennes ;
- B : Oxygénothérapie voire Intubation - ventilation assistée si :
DR - troubles de conscience - SCB > 60% – Brûlures cervicofaciales , Besoins analgésiques – Lésions d'inhalation
- C :

Remplissage : cristalloïdes 20ml/kg durant 1^{ère} heure ->si choc persistant -> colloïdes (Albumine : si SCB > 30 % + Albumine < 20g/l)

Catécholamines si besoin : Dobutamine : 5 ug/kg/minute ; Noradrénaline : 0,5 ug/kg/minute.

Réanimation hydroélectrolytique :

Formule Parkland Hospital :

1^{er} jour : 4ml/kg/%SCB Ringer lactate → dont 50% (2ml/kg/%SCB) durant premières 8h puis 50% pdt 16h restantes

2^{ème} jour : apports = moitié ceux apportés 1^{er} jour.

Formule Brooke :

1^{er} jour : 1,5ml/kg/%SCB Ringer lactate + 0,5ml/kg/%SCB colloïdes + 2000ml/j cristalloïdes

Formule Carvajal (enfant) :

1^{er} jour : 2000ml/m² surface corporelle totale + 5000ml/m² surface corporelle brûlée.

→ **OBJECTIFS** : PAM>70mmHg, FC<100bpm, diurèse+++.

b-Mesures adjuvantes :

- Sédation et analgésie : dérivées morphiniques+++.
- Nutrition : entérale+++ , parentérale.
- SAT-VAT, pas d'ATB systématique.
- Prévention des complications de décubitus, HBPM dose préventive.
- Mesures d'hygiène (draps stériles...).

c- Soins locaux des brûlures :

Lavage des brûlures avec un **savon antiseptique** (Bétadine®).

Rasage des zones brûlées et adjacentes.

Mise à plat des phlyctènes.

Rinçage à l'eau du robinet ou faiblement javellisée (bain).

Pansements à base de sulfadiazine d'argent pour prévenir l'infection.

4-Traitement chirurgical : 2 indications

Brûlures circonférentielles (tronc, extrémités, doigts) : aponévrotomie en urgence.

Brûlures profondes étendues : excision-greffe précoce.

5- Surveillance : clinique (constantes, diurèse, état pansements), biologie (hématocrite+++...) +/- imagerie.

CONCLUSION :

- Brûlures engagent pronostic vital immédiat => intérêt d'évaluation de gravité rapide + réanimation précoceintense.
- Séquelles graves (fonctionnelles, esthétiques et psychiatriques) => PEC multidisciplinaire.
- Intérêt de mesures préventives surtout en milieu de travail.